

Fecha Última Actualización: 18-10-2022 16:19:03

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Cristian Andrés Cofré Rioseco
Edad : 39a 2m 22d
Dirección : El Marmol 10310

Rut : 15.586.884-8
Fecha Nacto: 26/07/1983
Comuna : La Florida

N° Archivo : 2217889
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9020 7427

N° Epicrisis
323586

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 01/09/2022 21:54

Días Estadía: 47

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 18/10/2022 16:10

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

trauma

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Resumen hospitalización-Informe de traslado 18/10

FI CASR: 01.09.2022

FI UCI: 02.09.2022

FI SALA: 12/10

ANAMNESIS REMOTA

- Antecedentes médicos: No
- Antecedentes quirúrgico: No
- Fármacos: No
- Alergias: No
- Hábitos: Tabaco (-) , OH (-), drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: No

ANAMNESIS PRÓXIMA:

Paciente sin antecedentes conocidos ingresa el 01/09/22 traído por SAMU al ser encontrado posterior a accidente en moto, sin claridad en mecanismo de trauma, protecciones ni uso de casco al momento del impacto.

Ingresa al servicio de urgencias hemodinamicamente estable, eucárdico, saturando 100% MAF, comprometido de conciencia GCS 8, hemiplejía derecha, pupilas isocóricas y midriasis derecha, además, se observa tórax volante con enfisema subcutáneo con fast + para neumotórax; se observa también, deformidad en EII. Por tales condiciones se realiza IOT, pleurostomía derecha dando salida a contenido hemático y estabilización de extremidad comprometida.

Se realiza PAN TAC destacando edema cerebral ++, sin otras lesiones, lesiones intraabdominales a considerar posible desgarro de mesentérico, con hemoperitoneo laminar, hematoma suprarrenal derecho, leve neumotórax con tubo in situ, fracturas costales (1er arco) y apófisis transversa de C7. En extremidades se informa contenido hemático laminar en región poplíteica izquierda.

Por lo anterior es evaluado por TMT quien decide estabilización de luxofractura de rodilla izquierda en pabellón con tutores externos.

Posteriormente ingresa a UCI.

EXÁMENES DE INGRESO:

Fecha Epicrisis : 18/10/2022 16:19

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 18-10-2022 16:19:03

Página 2 de 4

01/09: Hb: 13.5 Hcto: 41 Leucocitos: 19220 RAN: 13000 RAL: 5400 Plaquetas: 250000 INR: 2.15 TTPA: 26.6 Ac lactico: 22,6 Creatinina: 1,05 BUN: 21,7 ELP: 140/3.49/107
02/09: pH: 7.408 oCO2: 34.7 pO2: 173.5 HCO3: 21.4 Hcto: 35 Hb: 11.4 BT: 0.65 FA: 45 GGT: 29 GOT: 174 GPT: 127 Calcio: 7.7 CK total: 3163 CK MB: 138 TUS <10

IMAGENES DE INGRESO:

01/09 panTAC: Aumento de densidad del meso del colon ascendente próximo al ángulo hepático. Considerar un desgarro mesentérico a ese nivel. Hemoperitoneo laminar. Hematoma suprarrenal derecho. Leve neumotórax derecho con tubo in situ. Enfisema parietal asociado cervicotorácico. Fracturas del primer arco costal posterior izquierdo y de la apófisis transversa izquierda de C7. Pequeño quiste renal izquierdo de aspecto simple.

TAC de encéfalo: edema cerebral ++ sin lesiones hemorrágicas o de ocupación parenquimatosa

TAC de columna cervical - pendiente informe

Luxofractura de rodilla izquierda que es evaluada por TMT - se decide estabilización en pabellón con tutores externos - procedimiento sin incidentes.

Es intervenido por neurocirugía para instalación de captor de PIC

En dichas condiciones se presenta a UCI para continuar manejo

DIAGNOSTICOS DE INGRESO

Politraumatismo

TEC cerrado grave

Edema cerebral - captor de pic - 02.09

Fx apofisis transversa izquierda c7

Obs esguince cervical

Trauma de torax

Fx costales multiples - torax volante

Hemoneumotorax derecho - pleurostomia 01.09

Obs contusion pulmonar y cardiaca

Trauma abdominal cerrado - neumoperitoneo laminar - hematoma suprarrenal

Luxofractura rodilla izquierda - estabilizada -02.09

Obs rabdomiolisis

EVOLUCIÓN DURANTE ESTADÍA

HDN/CV: Paciente ingresa con compromiso hemodinámico, necesidad de DVA las cuales se suspenden gradualmente. Resuelto. Sin conflicto actual.

Respiratorio: Ingresas con insuficiencia respiratoria en contexto de politrauma, se evidencia tórax volante con hemoneumotorax por lo que se instala pleurostomía el 01.09 retirada el 23/09. Evoluciona con buena mecánica ventilatoria. 14/09 Se procede a TQT, bajo visión fibrobroncoscopia sin incidentes, se logra extubación. Ocluida actualmente sin conflicto actual.

Neurológico: Paciente ingresa con compromiso de conciencia, RNM encéfalo evidencia edema cerebral por lo que se mantiene en VM protectora, evolucionando favorablemente con disminución del edema en imágenes por lo que se decide el día 07/09 iniciar weaning.

Desde el 07/09 evolucionó sin despertar adecuado, sin conexión al medio a pesar de suspensión de sedación, se sospecha mal pronóstico neurológico. Por sospecha de status epileptico no convulsivo, junto a neurología se agrega fenitoína EV y letericatecam enteral con carga, 13/09 EEG con disfunción lenta generalizada, manteniendose FAE.

TC de cerebro control 13/09 HSD agudo de tentorio izquierdo en reabsorción, HSA reabsorbida.

RNM cerebro 06/10 informe pendiente, impresionan signos de DAD grado 1, neurología indica que impresiona buen potencial de rehabilitación, mayor paresia proximal en extremidades podría estar en contexto de miopatía de paciente crítico por lo debe ser trasladado a centro de rehabilitación (CAPREDENA, Policenter) para este fin, una vez concretado y manejada parte traumatológica.

A la reevaluación por neurología 13/10, con plan de suspender fenitoína dado a que no ha presentado clínica de eventos

Fecha Epicrisis : 18/10/2022 16:19

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 18-10-2022 16:19:03

Página 3 de 4

comiciales, con NP infraterapéuticos. Fenitoína actualmente no está cumpliendo rol terapéutico. En cuanto alevetiracetam: El (03/10) se disminuye de 1 gr cada 12 hrs a 500 mg cada 12 hrs, con plan de en 14 días (17/10) bajar a 250 mg cada 12 hrs, luego en 21 días (21/10) 250 mg al día y finalmente suspender.

Infeccioso: Evolucionando con elevación de parámetros inflamatorios y fiebre por lo que se inicia tratamiento empírico con vancomicina + meropenem los cuales se ajustan según hemocultivos 06/09 1 y 2 positivos para K. Pneumoniae BLEE por lo que se indica tratamiento con imipenem + amikacina completando 14 días y posteriormente 13/09 se agrega ciprofloxacino por PAE completando 8 días. Además con vancomicina por celulitis en el brazo derecho completando 5 días. Evolucionando con nuevo HIT infeccioso con P. aeruginosa y K. pneumoniae en CAET el 08/09 por lo que se inicia tratamiento antibiótico con amikacina en NBZ el día 30/09 completando. Sin interurrencias infecciosas actualmente.

Renal/Medio interno: Al ingreso presenta elevación de CK total en contexto de politrauma, se maneja como rhabdomiólisis, sin falla renal, buena evolución clínica. Sin conflicto actual.

Traumatológico: Paciente ingresa con deformidad en EII, en TAC se informa contenido hemático laminar en región poplíteo izquierda. Por lo anterior es evaluado por TMT quien decide estabilización de luxofractura de rodilla izquierda en pabellón con tutores externos posteriormente retirados, actualmente con inmovilizador de rodilla. RNM rodilla 06/10: Rotura completa del LCA y colateral lateral y rotura de alto grado ligamento cruzado posterior. Esguince grado 1 ligamento colateral medial.

Foco de contusión ósea por impactación aspecto antero medial del compartimento interno.

Signo sugerente una lesión de esquina posterolateral con aparente lesión del tendón poplíteo y del bíceps.

Desgarro de ambos meniscos según descrito. Reevaluado por TMT rodilla Dr Sandoval, plan es rehabilitación con fortalecimiento isométrico de cuádriceps y favorecer ROM, marcha con bastones y al alta solicitar a la brevedad control con Dr Francisco Figueroa para resolución diferida, CDT PASillo 4

Rehabilitación: Evaluado por equipo de neurología quienes según última resonancia impresiona DAD grado 1 con buen potencial de rehabilitación. Mantener terapia kinésica full con el plan de traslado a centro de rehabilitación posterior. Tras retiro de SNG se decide no reinstalar, tras evaluación por fonoaudiología, con plan de régimen licuado y líquidos espesos. Cuantificar ingesta.

DIAGNÓSTICOS ACTUALES:

1. TEC Cerrado Grave
 - a. Edema Cerebral - Captor De Pic - 02.09
2. Trauma cervical
 - a. Fx Apófisis Transversa Izquierda C7
 - b. Obs Esguince Cervical
3. Trauma De Tórax
 - a. Fx Costales Múltiples
 - b. Hemoneumotórax Derecho - Pleurostomía 01.09 retirada el 23/09
4. Trauma Abdominal Cerrado
 - a. Neumoperitoneo Laminar - Hematoma Suprarrenal
5. Luxo fractura Rodilla Izquierda - Estabilizada -02.09. Rotura completa del pivote central asociada a la lesión de LCL y EPL.
6. Rhabdomiólisis
7. Sepsis,
 - a. Bacteriemia por KPN BLEE resistente a MERO sensible a IMI
 - b. Neumonía por PSA resistente a carbapenémicos, sensible a CIPRO
8. Trombosis venosa profunda braquial derecha al momento sin anticoagulación

Indicaciones

- Levetiracetam 250 mg c/12 hrs vo (21/10 bajar a 250 mg/día y dos semanas después suspender)
- Paracetamol 1 g c/8 horas vo
- Metamizol 300 mg SOS si dolor máximo cada 8 hrs por 3 días
- Risperidona 1 mg cada 12 horas VO

Fecha Epicrisis : 18/10/2022 16:19

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:57

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 18-10-2022 16:19:03

Página 4 de 4

Control en 1 mes con neurologo ambulatorio(sacar hora por paciente)

Control en 2 semanas con traumatologia Dr Francisco Figueroa en CDT pasillo 4 Hospital soter del rio (solicitar control a la brevedad, hora aun no agendada)

Control SOS en caso de nueva crisis convulsiva o compromiso de conciencia

Diagnóstico de Egreso

OTROS TRAUMATISMOS DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO -

Condición de Egreso Alta Otro Destino

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones, HDN estable, afebril.

Plan Post Alta

Traslado a capredena

Indicaciones

Tipo de Reposo : Levantar A Sillon

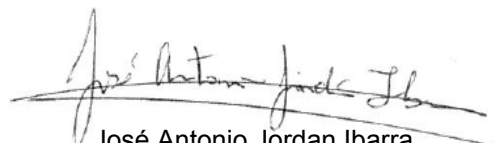
Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Eduardo Chinchón Gonzalez
Becado/Residente



José Antonio Jordan Ibarra
Médico Tratante (Staff)